

TEMA 1.12 • PEDIATRÍA

Reflujo, Dolor Abdominal y Constipación en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.046

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Reflujo, Dolor Abdominal y Constipación en Pediatría

1. Reflujo Gastroesofágico del Lactante

Reflujo Fisiológico (normal)

- **Clínica:** Lactante **feliz**, crece bien, regurgita después de comer - Pico entre los **2-6 meses**, desaparece habitualmente al año-año y medio - **Conducta:** Solo educación a los padres. Es normal y muy frecuente.

Reflujo Patológico (signos de alarma)

- **Mal incremento ponderal** (no crece) - Hemorragia digestiva - Síntomas respiratorios recurrentes (bronquitis obstructiva, asma por aspiración) - ALTE asociado a reflujo - Niño **irritable**, que llora, no duerme bien

Diagnóstico: Clínico ± pH-metría (para objetivar si hay duda).

• Tratamiento:

- **Omeprazol** (IBP) → primera línea (más eficaz que antihistamínicos H2)
- Domperidona u otros procinéticos → segunda línea
- Ranitidina/famotidina (antiH2) → alternativa si alergia a IBP

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los procinéticos (metoclopramida, domperidona) son antidopaminérgicos → riesgo de **síntomas extrapiramidales**. Usar como segunda línea.

Última línea (fracaso médico): Cirugía → **Funduplicatura de Nissen**

NOTA CLÍNICA

No confundir con **estenosis hipertrófica del píloro**: vómitos en **proyector** muy intensos entre 2-6 semanas de vida → ecografía → piloromiotomía de Ramstedt.

2. Dolor Abdominal Crónico en Niños

Manejo inicial: Anamnesis + examen físico → buscar signos de alarma.

Con signos de alarma (baja de peso, vómitos, hemorragia digestiva, focalidad, fiebre) → Estudio dirigido (ecografía, TAC, laboratorio) → tratar causa.

- **Sin signos de alarma** → **Dolor abdominal psicógeno** (causa más frecuente en niños):
- **Clínica:** Dolor **periumbilical**, aumenta con el estrés (exámenes, colegio), desaparece en vacaciones y fines de semana
- **Conducta:** Tranquilizar + educación + manejo del estrés

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En niños el dolor abdominal psicógeno es lo equivalente al SII del adulto. La clave es que el dolor sea periumbilical y se correlacione claramente con el estrés escolar.

3. Constipación y Fecaloma

Definición de Constipación en Niños

- ≤ 2 evacuaciones por semana - Deposiciones duras, en "caprinas" (bolas), o muy grandes - Dolor al defecar

Causa: Malos hábitos (poca agua, poca fibra, no ir al baño regularmente). Puede generar fisura anal → dolor → miedo al baño → **círculo vicioso**.

Fecaloma: Clínica

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El fecaloma **no siempre se presenta como constipación**. Su presentación clásica puede confundir:

- **Masa abdominal** (causa más frecuente de masa abdominal en pediatría)
- **Pseudoincontinencia fecal** (reboseamiento alrededor del fecaloma)
- **Encopresis:** Se hace caca mientras duerme (como "enuresis" pero fecal)
- Manchado de ropa interior
- Diagnóstico: masa en **tacto rectal** (siempre con testigo presente y registrado en ficha)

Tratamiento en 2 Etapas

- ##### Etapa 1: Desimpactación (sacar el fecaloma)
- **Primera línea: Polietilenglicol (PEG)** oral (laxante osmótico, el más eficaz en pediatría)
- **Alternativa equivalente:** Enema evacuante (fosfato)
- Si ambos fallan → **Proctoclis** (sonda intrarrectal con solución de lavado)
- Desimpactación manual: contraindicada (dolorosa, traumática)
- ##### Etapa 2: Mantenimiento (evitar recurrencia)
- **Laxantes al menos por 4 semanas** (romper el círculo vicioso, el niño no lo hará solo)
- Hábito de defecación: sentar al niño en el baño **5 minutos después del almuerzo** todos los días
- Educación sobre alimentación: aumentar fibra, frutas, agua

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 3 meses con regurgitaciones frecuentes luego de cada toma, sin irritabilidad, sin vómitos en proyectil, curva de peso adecuada. ¿Cuál es el manejo más apropiado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Reflujo, Dolor Abdominal y Constipación en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Reflujo fisiológico: regurgitaciones sin complicaciones <1 año; manejo: tranquilizar + espesar tomas
- ERGE patológica: esofagitis, aspiraciones, falla ponderal; omeprazol 1 mg/kg/día es primera línea
- Dolor abdominal crónico funcional: >3 episodios en 3 meses; periumbilical, psicógeno, examen normal
- Constipación: <3 deposiciones/semana; fecaloma = PEG oral + laxantes osmóticos por 4-6 semanas
- Invaginación intestinal: 5-18 meses; cólico + vómitos + deposición en jalea de grosella; enema diagnóstico-terapéutico
- Apendicitis aguda: dolor periumbilical → fosa ilíaca derecha; McBurney + Blumberg; eco/TAC; cirugía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (REFLUJO, DOLOR ABDOMINAL Y CONSTIPACIÓN EN PEDIATRÍA)

PREGUNTA 1

Lactante de 3 meses con regurgitaciones frecuentes luego de cada toma, sin irritabilidad, sin vómitos en proyectil, curva de peso adecuada. ¿Cuál es el manejo más apropiado?

- A) Omeprazol 1 mg/kg/día por 4 semanas
- B) Metoclopramida como procinético
- C) Espesar las tomas, posición semiincorporada y tranquilizar a la familia
- D) Cambiar a fórmula hidrolizada para descartar APLV
- E) Endoscopia digestiva alta para descartar esofagitis

PREGUNTA 2

Niño de 9 meses es traído por episodios de llanto intenso, encogimiento de piernas, vómitos y palidez. Entre los episodios está tranquilo. Deposición con aspecto en "jalea de grosella". ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A) Cirugía de urgencia sin estudios previos
- B) Enema con contraste o aire bajo control radioscópico (diagnóstico y terapéutico)
- C) Iniciar antibióticos EV por sospecha de colitis bacteriana
- D) Ecografía abdominal y si confirma, observación 48h
- E) Rehidratación oral y alta con control en 24h

PREGUNTA 3

Niña de 7 años con dolor abdominal recurrente de 5 meses, 3-4 veces por semana, periumbilical, de intensidad leve a moderada. Sin pérdida de peso, sin sangre en deposiciones, examen físico y hemograma normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Apendicitis crónica
- B) Enfermedad de Crohn
- C) Dolor abdominal crónico funcional (psicógeno)
- D) Infección por *Helicobacter pylori*
- E) Enfermedad celíaca

RESUMEN: REFLUJO, DOLOR ABDOMINAL Y CONSTIPACIÓN EN PEDIATRÍA

Tratamiento: 1. Omeprazol (IBP) → primera línea (más eficaz que antihistamínicos H2) 2. Domperidona u otros procinéticos → segunda línea 3. Ranitidina/famotidina (antiH2) → alternativa si alergia a IBP ::warning Los procinéticos (metoclopramida, domperidona) son antidopaminérgicos → riesgo de síntomas extrapiramidales. Usar como segunda línea. :::note No confundir con estenosis hipertrófica del píloro: vómitos en proyectil muy intensos entre 2-6 semanas de vida → ecografía → piloromiotomía de Ramstedt. :::